



EVALUATION SUJET : 59

POLYTRAUMATISME

Dr KHARRAT Sana

Pr CHTARA Kamilia

CHU Habib Bourguiba ,réanimation médicale, Sfax

Concernant le polytraumatisé

- A. C'est un patient qui présente deux lésions ou plus, dont une au moins menace le pronostic vital.
- B. C'est un patient dont le mécanisme du traumatisme prédit la présence de lésion qui menace le pronostic vital.
- C. c'est un patient qui présente des lésions dont l'évolution est indépendantes les unes des autres.
- D. La présence d'un décédé dans le même véhicule, témoigne de la gravité du mécanisme.
- E. Les traumatismes indirects (décélération, effet blast) sont obligatoirement responsables de lésions pariétales

Les critères de gravité pour le triage des patients traumatisés.

A. Âge > 45 ans

B. Une chute de deux mètres

C. Éjection d'un véhicule

D. Pression artérielle systolique < 90 mmHg

E. Saturation en O₂ < 90 %

Critères de Vittel : critères de gravité pour le triage des patients traumatisés.

Cinq étapes d'évaluation	Critères de gravité
Variables physiologiques	• Score de Glasgow < 13 • Pression artérielle systolique < 90 mmHg • Saturation en O₂ < 90 %
Éléments de cinétique	• Éjection d'un véhicule • Autre passager décédé dans le même véhicule • Chute > 6 m • Victime projetée ou écrasée • Appréciation globale (déformation du véhicule, vitesse estimée, absence de casque, absence de ceinture de sécurité) • Blast
Lésions anatomiques	• l'abdomen, du bassin, du bras ou de la cuisse • Volet thoracique • Brûlure sévère, inhalation de fumées associée • Fracas du bassin • Suspicion d'atteinte médullaire • Amputation au niveau du poignet, de la cheville, ou au-dessus • Ischémie aiguë de membre
Réanimation pré hospitalière	• Ventilation assistée • Remplissage > 1 000 ml de colloïdes • Catécholamines • Pantalon antichoc gonflé
Terrain (à évaluer)	• Âge > 65 ans • Insuffisance cardiaque ou coronarienne • Insuffisance respiratoire • Grossesse (deuxième et troisième trimestres) • Trouble de la crase sanguine

Concernant la prise en charge d'un polytraumatisé en pré hospitalier

- A. La stabilisation du rachis cervical est une priorité
- B. Un traumatisé crânien grave est considéré comme blessé médullaire jusqu'à preuve du contraire
- C. L'objectif du remplissage en préhospitalier est de ramener la PA systolique aux alentours de 110 mm Hg en absence de traumatisme crânien.
- D. L'intubation et l'assistance ventilatoire ne peuvent pas être envisagés en pré hospitalier.
- E. L'immobilisation des fractures est réalisée dès le ramassage.

Concernant la détresse neurologique

- A. L'état de coma chez un polytraumatisé est toujours en rapport avec traumatisme crânien.
- B. L'absence de signes de localisations chez un patient comateux élimine la présence des lésions du rachis cervicales.
- C. Les agressions qu'il faut éviter sont essentiellement l'hypotension artérielle et l'hypoxémie
- D. L'osmothérapie par mannitol ou sérum salé hypertonique en cas d' HTIC n'est pas envisagé en préhospitalier.
- E. Le contrôle des ACSOS doit être envisagé dès la phase préhospitalière des traumatisés crâniens sévères

Concernant l'état de choc chez un polytraumatisé

- A. Le choc cardiogénique est la forme la plus fréquente.
- B. La présence de turgescence des veines jugulaire est en faveur de l'origine hypovolémique du choc.
- C. L'état de choc peut être secondaire à un traumatisme médullaire.
- D. L'état de choc peut être secondaire à augmentation de la pression intrathoracique.
- E. Les fractures de membres peuvent être responsables d'un état de choc hémorragique.

Au cours de la phase d'accueil d'un polytraumatisé : les objectifs à atteindre

A. Une diurèse > 1ml/kg/h.

B. Une température centrale entre 36 et 37°C.

C. Une SpO₂ > 92 %

D. Une PAM proche de 60 - 70 mmHg, si l'hémorragie est contrôlée.

E. Une PAM à 80-90 mmHg, si traumatisé crânien et/ou médullaire grave.

Concernant la prise en charge d'un polytraumatisé à l'hôpital.

- A. Il faut surveiller la température et lutter contre l'hypothermie
- B. L'analgésie du patient doit être envisagée
- C. La voie sous Clavière doit être privilégiée en cas de nécessité d'une voie centrale
- D. IL faut mettre en place une sonde naso-gastrique en cas de traumatisme crânien avec coma.
- E. L'administration d'une antibioprophylaxie est obligatoire

Concernent la prise en charge opératoire:

- A. Il n'y a pas de stratégie standard qui est applicable à tous les polytraumatisés.
- B. La détresse respiratoire prime sur la détresse circulatoire
- C. La détresse neurologique prime sur la détresse respiratoire
- D. La détresse neurologique prime sur la détresse circulatoire.
- E. La lésion qui engage le pronostic vital prime sur celle qui engage le pronostic fonctionnel

Les traumatismes directs :

- A. Peuvent entraîner une atteinte des organes à distance
- B. Peuvent entraîner une atteinte des organes sous-jacents
- C. Peuvent être secondaires à des agents tranchants
- D. Peuvent être secondaires à une décélération
- E. Sont responsables de lésions pariétales

Les traumatismes indirects peuvent être secondaires à :

A. Un agent contondant

B. Un agent pénétrant

C. Une décélération

D. Une hyperflexion-extension brutale du rachis cervical

E. Une onde de choc de l'effet de souffle

Parmi les critères de gravité d'un polytraumatisé, on cite

A. Un volet thoracique

B. Un fracas du bassin

C. Un score de Glasgow entre 13-15

D. Une pression artérielle systolique < 90 mmHg

E. Une saturation en O₂ à 93 %

Le mécanisme d'un traumatisme est considéré grave si :

A. Le choc est violent avec une déformation du véhicule

B. La victime a chuté d'une hauteur de 1m

C. La victime est écrasée

D. La victime est éjectée du véhicule

E. Un autre passager est décédé dans le même véhicule

La détresse respiratoire chez un polytraumatisé est secondaire à :

- A. Un traumatisme crânien grave**
- B. Un traumatisme périphérique
- C. Un traumatisme maxillo-facial**
- D. Un traumatisme thoracique**
- E. Une lésion médullaire au dessous de C6

La détresse circulatoire lors d'un polytraumatisme est secondaire à :

A. Une contusion myocardique

B. Un pneumothorax compressif

C. Un traumatisme médullaire au dessous de T6

D. Une brûlure étendue

E. Une tamponnade

L'objectif de la prise en charge préhospitalière est

- A. Faire un bilan lésionnel complet
- B. Chercher et traiter les détresses vitales**
- C. Assurer le ramassage sans aggraver les lésions préexistantes**
- D. Prévenir l'hypothermie**
- E. Assurer le transport au centre hospitalier le plus approprié**

Un traumatisme thoracique est évoqué devant

- A. La présence des signes de lutte
- B. La présence d'une respiration paradoxale
- C. La présence d'une ecchymose thoracique
- D. L'existence d'une cyanose
- E. Une polypnée avec respiration ample

Les indications d'une intubation endotrachéale et ventilation mécanique chez un polytraumatisé sont :

- A. L'association d'un traumatisme thoracique et abdominale
- B. Le besoin d'une sédation-analgésie
- C. Une détresse circulatoire malgré une réanimation adéquate
- D. Une détresse neurologique avec score de Glasgow à 13
- E. Une détresse respiratoire non améliorée par une oxygénothérapie

Le diagnostic d'un état de choc hémorragique est évoqué devant l'association des signes suivants :

- A. L'existence d'un point d'impact abdominal
- B. L'existence d'une cyanose
- C. Une hypotension avec une différentielle pincée
- D. Une turgescence des veines jugulaires
- E. Une tachycardie

Un état de choc obstructif secondaire à un pneumothorax compressif est évoqué devant l'association des signes suivants :

A. Des râles sibilants à l'auscultation pulmonaire

B. Un emphysème sous cutané

C. Une pâleur cutanéomuqueuse

D. Une suffocation chez le blessé conscient

E. Une turgescence des veines jugulaires

Un état de choc obstructif secondaire à une tamponnade est évoqué devant l'association des signes suivants

- A. Un emphysème sous cutané
- B. Une abolition des murmures vésiculaires à l'auscultation
- C. Une diminution des bruits du cœur à l'auscultation
- D. Une suffocation chez le blessé conscient
- E. Une turgescence des veines jugulaires

La pression artérielle moyenne (PAM) chez le polytraumatisé avec une hémorragie non contrôlée doit être :

A. Entre 50-60mmHg

B. Entre 60- 70 mmHg

C. Entre 70-80 mmHg

D. Entre 75-85mmHg

E. Entre 90-100 mmHg

La pression artérielle moyenne (PAM) chez le polytraumatisé avec une hémorragie contrôlée doit être :

- A. Entre 50-60mmHg
- B. Entre 60- 70 mmHg
- C. Entre 70-80 mmHg
- D. Entre 75-85mmHg
- E. Entre 90-100 mmHg

Le taux de plaquettes chez un polytraumatisé avec un traumatisme crânien grave associé doit être :

A. Supérieure à 50000/mm³

B. Supérieure à 75000/mm³

C. Supérieure à 100000/mm³

D. Supérieure à 120000/mm³

E. Supérieure à 150000/mm³

Le taux de prothrombine chez le polytraumatisé doit être :

A. Supérieure à 40%

B. Supérieure à 50%

C. Supérieure à 60%

D. Supérieure à 70%

E. Supérieure à 80%

En arrivant à la salle de déchoquage, le polytraumatisé doit bénéficier sur le brancard et en urgence des examens paracliniques suivants :

A. Abdomen sans préparation

B. Echographie abdominale

C. Radiographie du bassin

D. Radiographie du rachis cervical

E. Radiographie de thorax

À combien évaluer vous le volume du saignement en cas de fracture tibiale?

A. 500 ml

B. 1000 ml

C. 2000 ml

D. 3000 ml

E. 5000 ml

À combien évaluer vous le volume du saignement en cas de fracture du fémur?

- A. 500 ml
- B. 1000 ml
- C. 2000 ml**
- D. 3000 ml
- E. 5000 ml

Quelle est la principale étiologie de l'EDC post traumatique

- A. Hypovolémique par hémorragie**
- B. Obstructif par pneumothorax
- C. Obstructif par hémothorax
- D. Septique par translocation digestive
- E. Cardiogénique par contusion myocardique

Quelle lésion doit elle être systématiquement évoquée devant tout traumatisme crânien?

- A. Traumatisme médullaire cervical**
- B. Traumatisme médullaire thoracique
- C. Traumatisme médullaire lombaire
- D. Syndrome de la queue de cheval
- E. Traumatisme costal

Quelles sont les causes d'éventuels troubles de l'hémostase

A. Déshydratation extra cellulaire

B. Hypothermie

C. Hypocalcémie

D. Transfusion de Culots globulaire à répétition

E. Acidose

Un traumatisme de l'hypochondre gauche peut causer une lésion:

- A. de la rate
- B. du pancreas caudal
- C. de la coupole diaphragmatique ipsilatérale
- D. de l'angle colique gauche
- E. du confluent bilio-pancréatique

Un traumatisme de la région ombilicale doit faire suspecter une lésion:

A. du pancréas

B. du grêle

C. des gros vaisseaux

D. du cadre colique

E. de la vessie

Au cours de l'évaluation de la gravité d'un polytraumatisme :

- A. Les traumatismes des membres ne modifient pas le pronostic du patient
- B. Le mécanisme de l'accident est un critère d'évaluation de la gravité
- C. Un âge jeune constitue un critère de gravité majeur
- D. La prise d'un médicament modifiant la crase sanguine est à considérer
- E. Elle doit se faire dès la prise en charge préhospitalière

Concernant la prise en charge d'un polytraumatisme en préhospitalier

- A. Elle doit commencer sur les lieux de l'accident
- B. L'intubation orotrachéale est indiquée si le score de Glasgow est inférieur à 9
- C. L'exsufflation d'un pneumothorax compressif ne peut pas être réalisée en absence de preuve radiologique
- D. Un remplissage vasculaire par 30ml/Kg de cristalloïdes doit être réalisé
- E. L'injection d'acide tranexamique est recommandée en cas d'état de choc hémorragique

Lors de la défaillance circulatoire post traumatique :

- A. La cause hémorragique est la plus fréquente
- B. La nature vasoplégique est évoquée quand la PAD est maintenue
- C. Le choc obstructif est suspecté en cas de turgescence des jugulaire et emphysème sous cutané
- D. Le choc obstructif est évoqué devant la turgescence des jugulaire et diminution des bruits du cœur
- E. Le choc cardiogénique est évoqué en présence de turgescence des jugulaires avec des râles crépitants

Concernant la prise en charge chirurgicale initiale d'un polytraumatisé :

- A. La présence d'un état de choc hémorragique non contrôlé indique une intervention chirurgicale urgente
- B. La prise en charge chirurgicale des lésions neurologiques doit être réalisée en premier lieu
- C. Aucun geste opératoire ne doit être réalisé si le taux d'Hb est inférieur à 10 g/dl
- D. Une thoracotomie d'hémostase ne peut pas être faite avant la réalisation d'un scanner thoracique
- E. Une laparotomie médiane peut être indiquée suite à la présence d'un épanchement à l'échographie au lit du malade

Concernant les mécanismes du polytraumatisme :

- A. Le blast provoque surtout des arrachements de pédicules vasculaires (foie, rate, aorte)
- B. L'hyperflexion-extension cervicale peut être responsable de fractures des vertébrales
- C. La décélération entraîne contusions, ruptures d'organes pleins et arrachements vasculaires
- D. Le syndrome d'écrasement expose surtout à une hypokaliémie avec myoglobininurie
- E. Le pronostic vital n'est pas engagé tant que toutes les lésions ne sont pas graves isolément

Concernant les associations lésionnelles :

- A. Le phénomène de sommation rend vitales plusieurs lésions mineures
- B. Le phénomène d'occultation signifie une lésion masque une autre
- C. L'association d'une insuffisance respiratoire et d'un coma illustre un phénomène d'aggravation
- D. Le coma permet d'écarter une atteinte du rachis
- E. Deux fractures isolées n'ont jamais d'impact pronostique

Dans la prise en charge préhospitalière du polytraumatisé, l'objectif tensionnel est :

A. PAS $\approx$ 80 mmHg quel que soit le contexte

B. PAM $\approx$ 60 mmHg chez tout patient

C. PAS $\geq$ 110–120 mmHg en cas de traumatisme crânien associé

D. PAS 90 mmHg en cas de suspicion de lésion médullaire

E. PAS 100 mmHg chez tout patient âgé

Les critères de Vittel incluent :

- A. GCS = 14, chute < 3 m, éjection d'un véhicule
- B. GCS < 13, chute > 6 m, éjection d'un véhicule
- C. PAS 95 mmHg, blast, suspicion de contusion pulmonaire
- D. GCS 12, PAS 100 mmHg, âge > 70 ans
- E. GCS < 9, PAS 85 mmHg, perte de connaissance initiale

Parmi les causes de détresse circulatoire chez le polytraumatisé, la plus fréquente est :

A. Hypovolémie hémorragique

B. Choc obstructif (tamponnade, pneumothorax compressif)

C. Choc cardiogénique post-contusion myocardique

D. Choc vasoplégique (lésion médullaire haute)

E. Hypovolémie par brûlures étendues

Le syndrome d'écrasement :

- A. Se complique typiquement d'une hypocalcémie
- B. Se complique typiquement d'une Hyperkaliémie
- C. Il est prévenu par remplissage et alcalinisation des urine
- D. Il peut évoluer vers une insuffisance rénale aiguë
- E. Il ne survient que dans les traumatismes directs

Dans la prise en charge d'un polytraumatisé :

- A. La détresse ventilatoire est prioritaire sur la circulatoire
- B. La détresse circulatoire est prioritaire sur la neurologique
- C. La neurologique prime toujours sur la détresse ventilatoire
- D. Les trois détresses sont équivalentes
- E. La priorité dépend uniquement du mécanisme

La « triade létale » du polytraumatisé associe :

A. Hypothermie

B. Acidose métabolique

C. Coagulopathie

D. Hyperkaliémie

E. Hypocalcémie

Le bilan radiologique initial urgent comporte :

A. Radiographie thorax

B. Radiographie bassin

C. Échographie abdominale (FAST)

D. Scanner corps entier immédiat

E. Scanner cérébral systématique

Chez le polytraumatisé, les causes de détresse respiratoire sont:

A. Contusion pulmonaire

B. Pneumothorax compressif

C. Volet thoracique

D. Traumatisme du rachis dorsal

E. Obstruction VAS

La stratégie de « damage control resuscitation » associe :

A. Ratio transfusionnel GR/PFC/Plaq $\approx$ 1:1:1

B. Correction précoce de l'hypocalcémie induite par les transfusions

C. Administration systématique de mannitol

D. Hypothermie thérapeutique

E. Limitation des apports de cristalloïdes

Devant un traumatisé inconscient (GCS 6) trouvé sur la voie publique :

- A. L'intubation orotrachéale n'est indiquée que si un état de choc est associé
- B. L'intubation orotrachéale est indiquée systématiquement**
- C. La mise en place d'une canule de Guedel suffit si ventilation spontanée
- D. On privilégie la ventilation non invasive en première intention
- E. L'intubation est contre-indiquée si suspicion de lésion cervicale

Dans le bilan lésionnel initial, l'échographie FAST sert surtout à :

A. Diagnostiquer une fracture costale

B. Détecter un épanchement intra-abdominal ou thoracique

C. Évaluer la volémie centrale

D. Mesurer la pression artérielle pulmonaire

E. Rechercher une lésion d'un organe creux

En cas de suspicion de lésion de l'aorte post traumatique :

A. L'échographie transthoracique suffit

B. L'angio-scanner thoracique est l'examen de choix

C. La radiographie thoracique peut montrer un élargissement du médiastin

D. L'IRM thoracique est obligatoire

E. On attend la stabilisation complète pour tout examen

La douleur du polytraumatisé :

A. Est traitée uniquement après stabilisation hémodynamique

B. Peut aggraver l'hypoxémie et l'état circulatoire

C. Peut entraîner une agitation entravant la prise en charge

D. Doit être systématiquement soulagée dès la prise en charge initiale

E. Les opioïdes ne peuvent pas être commencés en préhospitalier

cas clinique 1:

Homme de 28 ans, motard, conduit à 120 km/h heurté par une voiture.

Arrivée du SMUR :

GCS = 7/15 , anisocorie droite.

TA = 80/40 mmHg, FC = 140/min.

SpO₂ = 85 % sous masque O₂.

Thorax gauche : tympanique, abolition des MV.

eFAST : liquide libre abdominal.

QCM 1 — Priorités de prise en charge préhospitalière

A. Intubation orotrachéale avec protection de l'axe cervical

B. Perfusion de 3 L de NaCl 0,9 % rapide

C. Décompression thoracique gauche d'urgence

D. Transport immédiat au scanner corps entier

E. Mise en place d'un collier cervical rigide

QCM2 : Les causes possibles de l'état de choc sont:

A. Hémorragie intra-abdominale

B. Pneumothorax compressif

C. Tamponnade traumatique

D. Contusion myocardique

E. Hémorragie intracérébrale isolée

QCM 3 — La Stratégie thérapeutique en urgence hospitalière comporte

- A. Drainage thoracique gauche
- B. Laparotomie d'hémostase (damage control)
- C. Scanner corps entier avant le bloc
- D. Maintien d'une PAS ≥ 110 mmHg (TC associé)
- E. Transfusion de CG avec un objectif Hb >7 g/dl

Cas clinique 2 :

Homme de 35 ans retrouvé sous des gravats après effondrement d'un immeuble, coincé par Ses membres inférieurs pendant 6 heures.

TA = 95/60 mmHg, FC = 120/min.

Douleur intense des jambes, œdème, crépitation musculaire.

QCM1: Les risques immédiats à la levée de la charge sont:

A. Hyperkaliémie avec troubles du rythme

B. Hypocalcémie sévère

C. hypotension artérielle

D. Acidose métabolique

E. Coagulopathie de consommation

QCM2 : Les complications secondaires sont:

A. Insuffisance rénale aiguë par myoglobulinurie

B. Hypocalcémie transitoire

C. Syndrome de loge

D. Insuffisance respiratoire aiguë

E. Coagulopathie

QCM 3 — Mesures thérapeutiques initiales

- A. Remplissage intraveineux précoce et abondant
- B. Alcalinisation des urines
- C. Administration systématique de mannitol
- D. Surveillance électrocardiographique continue
- E. Décompression chirurgicale si syndrome compartimental

Cas clinique 3 :

Homme de 40 ans, accident de la voie publique, choc latéro-thoracique droit.

À l'arrivée au SAUV : PA = 85/50, FC = 130, SpO₂ = 88 %.

À l'examen : Pâleur cutanéomuqueuse, polypnée, thorax droit creux et douloureux, crépitants sous-cutanés.

Radiographie thorax : élargissement du médiastin, hémopneumothorax droit, fractures étagées.

QCM 1 — Les lésions post-traumatiques suspectées

A. Contusion pulmonaire sévère

B. Rupture de l'aorte thoracique

C. Volet costal

D. Rupture diaphragmatique

E. Contusion myocardique

QCM 2 — Examens complémentaires à demander sont:

A. Scanner thoracique avec injection (si état stabilisé)

B. Radiographie thorax de profil

C. Échographie pulmonaire

D. Angio-IRM thoracique en urgence

E. ECG + troponines

QCM :La prise en charge hospitalière comporte

- A. Mise en place d'un drain thoracique droit
- B. Oxygénothérapie avec objectif de SpO2 92 %
- C. Laparotomie exploratrice immédiate
- D. Transfusion sanguine avec un objectif de Hb à 10 g/dl
- E. La pose d'un cathéter veineux central en sous clavier

Cas Clinique 4

Homme de 50 ans, chute de 5 m.

Constantes : PA = 100/60, FC = 90, SpO₂ = 96 %.

GCS = 15/15, mais paraplégie flasque avec abolition des ROT aux MI.

QCM 1 — Les Hypothèses diagnostiques:

- A. Section médullaire complète au niveau D12
- B. Contusion médullaire dorsale
- C. Hématome extradural rachidien compressif
- D. Fracture instable avec compression médullaire
- E. Lésion plexuelle lombaire bilatérale

QCM2 :Examens complémentaires

A. Scanner du rachis dorsolombaire

B. IRM médullaire

C. Radiographie standard en incidence dynamique

D. Ponction lombaire

E. Électromyogramme en urgence

QCM3: Le bilan lésionnel a conclu à un traumatisme du rachis dorsal avec fracture corporéale de D12 et recule du mur postérieur avec rétrécissement du canal médullaire de 50 %, La Prise en charge initiale

A. Immobilisation stricte de l'axe tête-cou-tronc

B. Collier cervical rigide systématique

C. Corticothérapie IV haute dose systématique

D. Réalisation précoce d'une fixation chirurgicale si fracture instable

E. Surveillance neurologique rapprochée en réanimation

CAS CLINIQUE QCM

Un Homme de 25 ans, victime d'un AVP

Il a été éjecté à 10 m de sa voiture pendant le choc

À l'arrivée des secours: le patient n'ouvre pas les yeux à la douleur, ne parle pas et il a un mouvement en retrait des mains au pincement de celles-ci

L'abdomen est souple à la palpation

Le bras droit et la jambe droite sont sièges de volumineux hématomes et le tronc ainsi que le visage comportent de nombreuses plaies

2 cotes adjacentes semblent être tuméfiées en 2 foyers différents

PA =70/45, FC=120/min, SpO2=97%, T°=35,9°C

Quel est le score de Glasgow de ce patient?

A. 5 (E1-V1- M3)

B. 6 (E1-V1-M4)

C. 7 (E2 -V1- M4)

D. 8 (E2- V1-M5)

E. 9 (E2- V2- M5)

Un remplissage vasculaire par sérum salé isotonique à 0.9%

Transport à l'hôpital par le SAMU

Sa PA=67/40 (après 1000 cc) , FC=125/min

GAD 5.6 mmol/l, Hb = 6g/dl

Le bilan radiologique de 1ère intention comporte:

- A. Scanner corps entier injecté
- B. Radiographie du thorax de face
- C. Radiographie des membres supérieurs
- D. Échographie abdominale
- E. Radiographie du bassin de face

Lequel (lesquels) de ces dosages sanguins peut(peuvent) être utile (s) à la prise en charge?

A. Groupe sanguin

B. CRP

C. Recherches d'agglutinines irrégulières

D. Bilan d'hémostase

E. Gazométrie artérielle

Le patient est stabilisé sur le plan hémodynamique. La radiographie thoracique confirme la présence de 2 foyers de fracture sur la 4ème cote droite et 2 foyers de fracture sur la 5ème cote droite sans atteinte des autres côtes. quelles anomalies peut on retrouver sur le body scanner

- A. Pneumothorax**
- B. Volet thoracique
- C. Hémothorax**
- D. Rupture diaphragmatique
- E. Lésion splénique

Cas clinique-QCM2

De garde au SAMU, vous êtes appelé sur les lieux d'un AVP pour PEC d'un polytraumatisé de 19 ans.

À l'examen:

PA=65/30 mmHg, Fc=130/min, SpO2=86%,

T°=37.4

Plaie du scalp de 4x2 cm, dermabrasions au niveau des 4 membres

SG 8/15

Déformation du membre inférieur droit évoquant une fracture tibiale

Quels sont les moyens de la mise en condition immédiate?

- A. Respect de l'axe tête –cou-tronc
- B. Mise en place d'un collier cervical
- C. Pose d'un cathéter veineux central en position fémorale
- D. Intubation orotrachéale pour ventilation mécanique
- E. Sondage urinaire

Quelles mesures thérapeutiques immédiates mettez-vous en œuvre?

- A. Expansion volémique par sérum glucosé 5%
- B. Expansion volémique par sérum salé isotonique
- C. Stabilisation du foyer fracturaire du membre inférieur droit au moyen d'une attelle
- D. Stabilisation du foyer fracturaire du membre inférieur droit au moyen d'un pantalon anti choc
- E. Antibiothérapie intraveineuse à large spectre par imipenème

Les mesures suivantes ont été mises en œuvre

Stabilisation du rachis cervical et du foyer fracturaire/

IOT + VM avec FiO2 100%/ 2 VVP + remplissage par Ss isotonique

L'hypotension persiste, quel médicament choisissez vous?

A. Dobutamine

B. Noradrénaline

C. Dopamine

D. Isoprénaline

E. Amiodarone

Quels examens complémentaires d'imagerie réalisez-vous à l'arrivée à la salle de déchoquage?

A. Radiographie thoracique

B. Radiographie du bassin

C. Échographie abdominale

D. Échographie pleurale

E. Scanner cérébrale

**Le patient a été stabilisé après sa mise sous catécholamines.
Quelles mesures thérapeutiques mettez vous en œuvre avant
la poursuite des explorations**

**A. Monitoring invasif de la PA après pose d'un cathéter
artériel**

B. Mise en place d'un cathéter veineux central sous clavier

C. Suture de la plaie du scalp

D. Sérovaccination antitétanique

E. Pose d'une sonde urinaire

Cas clinique-QCM

Un patient âgé de 25 ans sans antécédent victime d'une chute du troisième étage (environ 10m).

Transporté par la protection civile au service des urgences, l'examen initiale trouve:

FR à 20 cycles/mn, une bonne ampliation thoracique. Les MV sont bien perçus et symétriques. La SpO2 est indétectable

PA 60/30 mm Hg, FC 130 battements/mn, une froideur des extrémités et des conjonctives décolorées

Il n'ouvre pas les yeux à la stimulation douloureuse, localise la douleur et absence de réponse verbale

Un abdomen ballonné, une fracture ouverte de la jambe gauche

Calculer le score de Glasgow :

A. 12/15

B. 9/15

C. 7/15

D. 6/15

E. 3/15

le(s) critère(s) qui gravité immédiate chez ce patient selon Vittel

A. La présence d'une pression artérielle systolique < 65 mm Hg

B. Une fréquence cardiaque à 130

C. La chute du troisième étage (environ 10 m)

D. La présence d'un abdomen ballonné

E. Le coma

La prise en charge hémodynamique de ce patient doit comporter en urgence :

A. Un remplissage vasculaires par les cristalloïdes

B. L'administration de la dobutamine

C. L'administration de la noradrénaline

D. La mise en place d'un cathéter sous clavier pour le remplissage

E. Un monitoring continu de la pression artérielle par un cathéter artériel

Le bilan biologique obligatoire urgent à l'arrivée du patient comporte

A. Un groupe sanguin

B. Une NFS

C. Un bilan d'hémostase

D. Urée -créatinine

E. Un ionogramme sanguin

Le bilan lésionnel initial (radio thorax , radio bassin et fast echo) a montré la présence d'un hémopéritoine de grande abondance en rapport avec une lacération de la rate, La CAT comporte .

- A. Le bilan lésionnel doit être complété par un body scanner
- B. Le patient doit être admis en réanimation pour stabilisation de son état hémodynamique.
- C. Le patient doit être acheminé immédiatement au bloc opératoire pour parage suture et ostéosynthèse de sa fracture de jambe.
- D. Le patient doit être acheminé immédiatement au bloc opératoire pour une splénectomie d'hémostase**
- E. Le patient doit être surveillé en milieu de réanimation et opté pour un traitement non opératoire de la lésion splénique.

Cas clinique-QCM.

Un homme âgé de 43 ans victime d'un AVP suite à un dérapage de sa voiture vers minuit. Il était conducteur, avec ceinture de sécurité, avec décès sur place de sa femme.

L'examen initial par l'équipe de SAMU objective :

*Un patient obnubilé et agité, il se plaint d'une douleur au niveau de l'hypochondre gauche et de la cuisse gauche,

*Il n'avait pas de déficit moteur et ses pupilles étaient en position intermédiaire, symétriques et réactives. Avec notion de PCI

. *PA 75/50 mmHg, le pouls était symétrique et régulier à 140/min et les extrémités froides.

La respiration était superficielle et rapide à 40 cycle /min associé à une abolition du murmure vésiculaire dans tout le champ pulmonaire gauche. La SpO2 est à 80% à l'air ambiant.

Les critères de gravité que présente ce patient selon Vittel

A. le décès de sa femme

B. l'agitation

C. Notion de PCI

D. la PA 75/50mmHg

E. la respiration superficielle et rapide à 40 cycle/min

la cause la plus probable de la détresse respiratoire chez ce patient.

A. Une pneumopathie d'inhalation

B. Un pneumothorax

C. Une embolie pulmonaire

D. Un OAP Cardiogénique

E. Une dissection de l'aorte

Les causes les plus probables de la détresse circulatoire chez ce patient.

A. Un choc obstructif

B. Un choc cardiogénique

C. Un choc septique

D. Un choc vasoplégique

E. Un choc hémorragique

Ce patient doit bénéficier en urgence sur le lieu du traumatisme de :

- A. Instauration d'une oxygénothérapie**
- B. Une l'exsufflation du pneumothorax à l'aiguille**
- C. Mise en place de d'une voie veineuse centrale
- D. Un remplissage vasculaire par des cristalloïdes**
- E. Introduction d'emblée de catécholamine

En plus de la stabilisation des fonctions vitales le patient doit bénéficier de :

A. Mise en place d'une sonde gastrique

B. Réchauffement et lutter contre l'hypothermie

C. Une sonde vésicale

D. Une analgésie

E. Une immobilisation du membre inférieur gauche.

Ce patient est acheminé au bloc opératoire. Il a à l'échographie abdominale un épanchement intrapéritonéal de grande abondance en rapport avec un fracas de la rate. Son bilan biologique initial objectivé Hb = 6,4 g/dL, leucocytes = 14 500/mm³, plaquettes = 30 000/mm³ ; TP = 28 %, Fg 1,2g/dl

Chez ce patient

- A. L'administration de l'acide tranexamique se fait qu'après la transfusion des CG et des PFC.
- B. Il faut transfuser par des produits sanguins avec un ratio 01 CG / 01 PFC.
- C. Il faut administrer du fibrinogène.
- D. Il faut administrer des culots plaquettaires
- E. L'administration du PPSB est obligatoire